Les Fondements Théoriques de la Clinique de l'Activité

Pr. Christine LAGABRIELLE (Professeure des universités, Cnam Nouvelle-Aquitaine / Paris)

Séance du Jeudi 5 novembre 2026 (20h00 – 21h06) · Classe virtuelle BigBlueButton · Transcription intégrale certifiée (6 367 mots).

THÈSE CENTRALE DE LA SÉANCE

Pour fonder la Clinique de l'Activité dans les années 1990 face aux violences de l'individualisation néomanagériale, Yves Clot opère une triple hybridation épistémologique : 1) La psychologie historico-culturelle russe (Vygotski, Léontiev, Engeström) fondant l'activité comme système social médiatisé ; 2) La philosophie du dialogue (Bakhtine, Boutet) théorisant la polyphonie et la parole empêchée ; 3) La philosophie médicale de Georges Canguilhem redéfinissant la santé comme pouvoir d'agir et « normativité ». Cette articulation substitue la quête vitale du « bien-faire » aux illusions gestionnaires du « bien-être ».

École Russe (Vygotski, Léontiev) · Système d'activité (Engeström) · Dialogisme & Polyphonie (Bakhtine) · Formation langagière lacunaire (Boutet) · Santé comme Normativité (Canguilhem) · Psychothérapie institutionnelle (Tosquelles) · Réel de l'activité (Clot) · Du bien-être au bien-faire

1 Contexte d'Émergence & Filiations : Répondre aux Dérives Néomanagériales (00:00 – 00:10)

Pr. Christine Lagabrielle rappelle que la clinique de l'activité ne surgit pas dans un ciel serein : elle s'élabore dans les années 1990 en réaction directe aux mutations brutales de l'organisation du travail :

- **Le terreau des réformes gestionnaires** : Généralisation de l'évaluation individualisée des performances, dérégulation et flexibilisation, travail en flux tendu, restructurations permanentes depuis les années 1980 et montée conjointe d'une insécurité d'emploi réelle et subjective chez les salariés.
- **L'impasse de la psychologisation** : Ces organisations anonymes génèrent une souffrance croissante qu'elles prétendent traiter par des artifices individuels (écoute privée, coaching), renvoyant le salarié à son for intérieur.
- **Une communauté scientifique collective** : La clinique de l'activité s'est construite avec de nombreux chercheurs du Cnam, notamment **Yvon Miossec** (coopération conflictuelle et ressources génériques) et **Dominique Lhuilier** (santé et clinique médicale du travail), et en dialogue interdisciplinaire avec des juristes comme **Loïc Lerouge** (CNRS Bordeaux, spécialiste de la santé au travail dans les PME).

2 L'École Russe Historico-Culturelle : Vygotski & Léontiev (00:10 – 00:23)

Pour dépasser le béhaviorisme pavlovien (stimulus-réponse) et l'ergonomie comportementale pure, Yves Clot puise chez les pionniers soviétiques des années 1920 (**Lev Vygotski**, **Alexeï Léontiev**, **Alexandre Luria**) qui fondent une psychologie socio-constructiviste d'inspiration marxiste :

- **Le sujet est intrinsèquement social** : Le développement de la pensée ne relève pas d'une maturation biologique autonome ; il est médiatisé par les instruments culturels et le langage.
- **Transposition de la Zone Proximale de Développement (ZPD) au travail** : Vygotski démontre que *« ce que le sujet peut faire aujourd'hui en coopérant avec autrui, il pourra le faire seul demain »*. Clot en déduit un principe cardinal : **le travailleur fait infiniment plus et mieux lorsqu'il s'adosse à un collectif** que lorsqu'il est livré à lui-même.
- **La Théorie de l'Activité d'Alexeï Léontiev (1975)** : Toute activité humaine repose sur deux registres (matériel/concret et idéal/psychologique) et s'organise en trois niveaux emboîtés (Paul Olry, 2019) :

NIVEAU D'ANALYSE	ORIENTATION PSYCHOLOGIQUE	DÉFINITION CONCEPTUELLE	EXEMPLE CONCRET (INFIRMIÈRE)
1. L'Activité (Global)	Orientée par le **Motif** (Besoin social / Motive)	Niveau le plus large répondant au sens de la présence du sujet dans son milieu.	Soigner les malades, soulager la souffrance et préserver la vie humaine.
2. L'Action (Intermédiaire)	Orientée par le **But conscient** (Goal)	Processus cognitif subordonné à un objectif précis représenté par l'opérateur.	Réaliser la réfection du pansement d'escarre d'un patient à 10h.
3. L'Opération (Concret)	Orientée par les **Conditions** matérielles (Means)	Micro-gestes sensorimoteurs automatisés dictés par les contraintes de l'outil et du lieu.	Manipuler la pince stérile, ouvrir le flacon d'antiseptique d'un geste précis du poignet.

3 L'Approche Systémique : Le Modèle du Système d'Activité d'Yrjö Engeström (00:42 – 00:50)

Le modèle initial de Vygotski (Sujet – Outil – Objet) ne rendait pas suffisamment compte de la complexité institutionnelle. Le psychologue finlandais **Yrjö Engeström** (théorie de l'activité de 3e génération) élargit ce schéma en démontrant qu'**aucune activité n'est purement individuelle**. Même un geste solitaire s'inscrit dans un milieu social et s'adresse symboliquement à d'autres :

PÔLE DU SYSTÈME	DÉFINITION CONCEPTUELLE	ILLUSTRATION CLINIQUE : LE PANSEMENT INFIRMIER	TENSION / CONTRADICTION POSSIBLE
Sujet	L'opérateur individuel ou le collectif engagé dans l'action.	L'infirmière diplômée d'État en poste dans un service hospitalier.	Fatigue corporelle, sous-effectif, charge mentale.
Outils (Artefacts)	Médiateurs matériels (instruments physiques) et symboliques (langage, écrits).	Compresses, antiseptiques (matériels) + protocole de soins et dossier patient (symboliques).	Rupture de stock stérile, logiciel de traçabilité chronophage et rigide.
Objet (Visée)	La matière travaillée et la transformation visée pour le destinataire.	La plaie du patient à déterger et cicatriser pour restaurer sa santé.	Plaie atypique non prévue par la nomenclature officielle.
Règles	Normes explicites (législation, hygiène) et implicites (coutumes de service).	Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), charte de bientraitance.	Contradiction : temps prescrit (5 min) vs temps d'asepsie requis (15 min).
Communauté	Le groupe de pairs, usagers et acteurs partageant le même objet de travail.	L'équipe de soins du service, les collègues de relève, le patient et sa famille.	Isolement si les temps d'échange informels sont supprimés.
Division du travail	Répartition horizontale et hiérarchique des tâches et du pouvoir de décision.	Prescription par le médecin chef, binôme avec l'aide-soignante, encadrement cadre.	Cadre de santé déconnecté du terrain prescrivant l'inapplicable.

Application méthodologique pour l'examen : Utiliser la triade étendue d'Engeström pour toute analyse de situation clinique : cartographier les tensions systémiques entre les exigences des Règles (HAS/budget), les Outils inadaptés et la Division du travail qui entrave la Communauté soignante.

4 L'Apport Linguistique & Littéraire : Mikhaïl Bakhtine & Josiane Boutet (00:23 – 00:32)

Yves Clot accomplit un déplacement fécond en important la théorie littéraire de **Mikhaïl Bakhtine** (1977) et la sociolinguistique de **Josiane Boutet** (réseau Langage et Travail) pour analyser le travail réel :

- **Polyphonie et Dialogisme (Bakhtine)** : Aucun discours n'est vierge ou premier. Toute parole est habitée par d'autres voix (polyphonie) et s'inscrit comme un maillon dans une chaîne ininterrompue d'actes de parole qui répondent, contestent ou prolongent des discours antérieurs. Appliqué au travail : un geste professionnel n'est jamais purement individuel ; il est traversé par les manières de faire des anciens et orienté vers un destinataire (le patient, le collègue, la hiérarchie).
- **La vérité comme quête dialogique** : Bakhtine affirme : *« La vérité ne se trouve pas dans l'esprit d'un individu isolé. Elle naît entre des personnes qui la recherchent collectivement au cours de leur interaction dialogique. »* Clot s'appuie sur cette formule pour asseoir la légitimité des controverses de métier.
- **Le travail comme « formation langagière lacunaire » (Josiane Boutet)** : Pr. Lagabrielle met en lumière le drame linguistique du travail : alors que nous disposons de mots quotidiens partagés pour parler de nos enfants, de notre sexualité ou d'un film, **le travail est très peu codé dans la langue commune**. Il n'existe que des discours d'experts (ingénieurs, ergonomes, juristes). L'ouvrier ou l'infirmière est confronté à un manque cruel de mots pour dire l'intime du métier, la douleur corporelle ou la souffrance de la chaleur, d'où la nécessité clinique d'outiller la parole sur le travail réel.

> *« Toute énonciation, même sous forme figée, est une réponse à quelque chose et est construite comme telle. Elle n'est qu'un maillon dans la chaîne des actes de parole. »*
>
> **— Mikhaïl BAKHTINE (1977) cité par Pr. Christine Lagabrielle**

5 La Santé comme Normativité & Pouvoir d'Agir : Canguilhem & Tosquelles (00:32 – 00:41)

Pr. Christine Lagabrielle insiste sur la rupture philosophique opérée par **Georges Canguilhem** dans *Le normal et le pathologique* (1966), essentielle pour tout psychologue du travail :

- **Contre la réduction quantitative** : La santé ne se résume pas à un état biologique moyen ou à des constantes sanguines qui ne dépassent pas les bornes d'un laboratoire. Être malade est normal dans le vivant (anecdote de Dejours : myopie, ongles, fatigue).
- **La santé est une Normativité** : La vie est une activité créatrice qui consiste à poser des normes et à pouvoir les modifier face aux infidélités du milieu. **La santé, c'est le pouvoir de tomber malade et d'en guérir**, c'est la capacité du sujet à instituer de nouvelles normes de vie face aux épreuves.
- **La santé au travail = Pouvoir d'agir sur son milieu** : Se sentir en santé, c'est se sentir *« plus que normal »*. Au travail, la santé réside dans la possibilité de transformer son environnement pour le rendre vivable. **La pathologie s'installe dès lors que ce pouvoir d'agir sur le milieu est durablement confisqué par l'organisation.**
- **François Tosquelles et la Psychothérapie Institutionnelle** : Psychiatre catalan réfugié à Saint-Alban, Tosquelles démontre la centralité thérapeutique du travail : travailler permet d'échapper à l'inactivité et de renouer avec le réel. Formule d'école : *« Pour soigner les malades, il faut d'abord soigner l'institution. »*

DIMENSION	MODÈLE BIOMÉDICAL / GESTIONNAIRE CLASSIQUE	MODÈLE CLINIQUE NORMATIF (CANGUILHEM & CLOT)
Statut de la santé	Conformité passive à une moyenne statistique quantitative.	**Normativité** : capacité dynamique à poser et réinventer ses propres normes.
Critère d'évaluation	Absence de TMS, de burn-out ou d'arrêt maladie déclaré.	**Pouvoir d'agir préservé** : capacité à intervenir sur le milieu et à faire face à l'imprévu.
Traitement de la détresse	Mesures de « bien-être » individuel (écoute psychologique, coaching).	Restauration du **« bien-faire »** : déblocage des empêchements organisationnels du métier.

6 Le Réel de l'Activité & le Passage « Du Bien-Être au Bien-Faire » (00:50 – 01:00)

Pr. Christine Lagabrielle lit et commente un texte princeps d'Yves Clot explicitant pourquoi l'activité ne peut jamais être réduite au comportement observable :

> *« **Le réalisé n'a pas le monopole du réel.** Ce qui se fait n'est jamais que l'actualisation d'une des actions réalisables... Dans ce que je fais, il y a aussi ce que je n'ai pas pu faire, ce que j'aurais aimé faire, ce qu'on cherche à faire sans y parvenir (le drame des échecs), et ce qu'on fait pour ne pas faire ce qui est à faire. Faire, c'est tout autant refaire ou se défaire, comme dire est tout autant redire que se dédire. »*
>
> **— Yves CLOT cité par Pr. Christine Lagabrielle (00:51:26)**

De cette analyse découle le grand basculement professé par l'enseignante : **Du bien-être au bien-faire** :

- **L'activité retournée contre le sujet** : La souffrance mentale au travail n'est pas un problème de « bien-être » ou de sensibilité fragile. Elle naît quand le cycle de l'activité est rompu : le travailleur sait ce qu'est un travail soigné, mais les conditions matérielles l'empêchent de le réaliser dans les règles de l'art. Dès lors, l'activité se retourne contre lui et ampute sa santé.
- **La formule cardinale sur les conflits** : Pr. Lagabrielle formule la punchline d'or d'Yves Clot :

  « Si les conflits de travail ne sont pas parlés, ne sont pas discutés, ne sont pas disputés, alors ces conflits vont inévitablement se transformer en conflits de personnes. »

- **La dispute professionnelle comme issue thérapeutique** : La seule manière de pacifier les relations d'équipe n'est pas d'organiser du team-building, mais de restaurer des espaces de controverse réglée entre gens de métier sur les critères de la qualité. *« Pas de beau travail sans se reconnaître dans des règles de métier et sans critères de qualité élaborés collectivement. »*

7 Fiche Réflexe Examen Titre RNCP : 6 Punchlines & 4 Pièges Éliminatoires

6 FORMULES D'OR INCONTOURNABLES DE LA SÉANCE	4 CONTRESENS ET PIÈGES ÉLIMINATOIRES AU CNAM
1. *« Le réalisé n'a pas le monopole du réel »* (Clot). **2.** *« Si les conflits de travail ne sont pas disputés sur le travail bien fait, ils se transforment en conflits de personnes »* (Clot). **3.** *« La santé, c'est la normativité : la capacité d'instituer de nouvelles normes face aux épreuves »* (Canguilhem, 1966). **4.** *« Ce que le travailleur fait en coopération aujourd'hui, il le fera seul demain »* (Vygotski / ZPD). **5.** *« Pour soigner les malades, il faut d'abord soigner l'institution »* (Tosquelles). **6.** *« Le travail est une formation langagière lacunaire qui manque de mots pour dire l'intime »* (Boutet, 2008).	**Piège 1 : Le réductionnisme comportemental** Réduire l'activité réelle à ce qui est observable ou chronométrable, en oubliant l'empêché, le suspendu et le drame des échecs. **Piège 2 : L'illusion du « bien-être » individuel** Proposer de la relaxation ou de l'écoute privée au lieu d'intervenir sur les empêchements organisationnels du « bien-faire ». **Piège 3 : La normalité statistique** Confondre la santé canguilhémienne (normativité active) avec une norme médicale moyenne passive ou l'absence de symptômes. **Piège 4 : La psychologisation des querelles** Traiter les conflits d'équipe comme des problèmes relationnels d'ego alors qu'ils sont le fruit de conflits de métier étouffés.

8 Consignes Orales de Pr. Lagabrielle & Calendrier de la Suite du Cursus

1. Clôture de la partie historique magistrale : Pr. Christine Lagabrielle a officiellement achevé le cycle de cours magistraux retraçant les jalons historiques de la psychologie du travail. Jessica Roussan prend intégralement le relais sur les classes virtuelles et ateliers pratiques en sous-groupes (dès le vendredi 6 novembre en distant et le jeudi 12 novembre pour l'analyse des cas concrets de catachrèse et de règles de métier).

2. Regroupement Présentiel au Cnam Bordeaux (Samedi 28 novembre 2026 à 14h00) : Première séance en présentiel avec Pr. Lagabrielle dédiée à la modélisation de la santé au travail en clinique de l'activité, confrontée aux autres approches de la discipline, et analyse collective d'études de cas de terrain.

3. Ressources obligatoires à consulter : Visionner la conférence filmée d'Yves Clot et Loïc Lerouge à la librairie Mollat (Bordeaux) sur la santé au travail dans les PME ; étudier les fiches 23 et 26 de l'ouvrage *Psychologie du travail et des organisations en 40 fiches visuelles* (Dunod) en corrigeant la coquille page 10 (Wilhelm Wundt = 1879 et non 1979).